L’équilibre financier d’un projet à l’hôpital

Philippe. Dehaspe

31 mars 2025

1. Remarques préliminaires
2. Les finances d'un hôpital – Recettes et dépenses
3. Mesurer la rentabilité d'un projet
4. Votre projet

1. Remarques préliminaires
2. Les finances d'un hôpital – Recettes et dépenses
3. Mesurer la rentabilité d'un projet
4. Votre projet

REMARQUE IMPORTANTE

du directeur financier…

L'évaluation économique, si elle est le seul critère de choix dans une entreprise commerciale,
ne peut être le seul critère de choix à l'hôpital.

Le but de l'hôpital est de générer des moyens destinés à être engagés dans son objectif social. Il n'est donc pas anormal que certains moyens soient engagés sans marge bénéficiaire, ou même avec une marge négative.

CEPENDANT

L'évaluation économique doit être réalisée dans tous les cas, pour comprendre l'impact réel d'un projet sur les moyens futurs (impact sur la qualité des soins, les consommables, le personnel nécessaire, etc.).

Autre remarque importante

Tout ce qui va suivre est (très) simplifié…

- Le but de cette présentation est de donner les grandes lignes des raisonnements à suivre dans l'évaluation des projets à l'hôpital
- En réalité la comptabilité est une matière complexe, et les règles spécifiques qui s'appliquent aux hôpitaux la rendent encore un peu plus complexe.

- Nous avons donc simplifié ces principes pour vous permettre de les appliquer dans les grandes lignes sans perdre de temps sur les fioritures qui mobilisent des dizaines d'heures de cours pour les ingénieurs de gestion.

1. Remarques préliminaires
2. **Les finances d'un hôpital – Recettes et dépenses**
3. Mesurer la rentabilité d'un projet
4. Votre projet

Les Finances d’un hôpital

Introduction

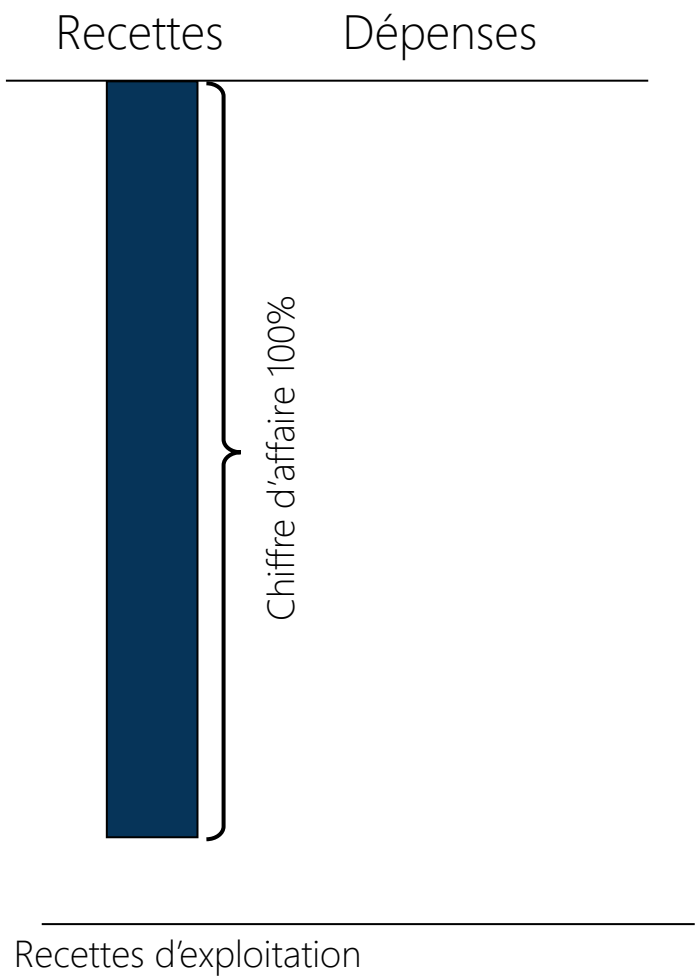
- Le fonctionnement d’un hôpital est extrêmement règlementé, dans toutes ses dimensions, y compris financières.
- Tous les hôpitaux ont donc la même structure de recettes et de dépenses, la différence entre les deux formant le bénéfice (ou la perte ☹)
- En fonction du type d’hôpital, le poids relatif des différentes rubriques va varier, mais tous les ingrédients sont présents partout

Chacun de vos projets influencera les recettes et/ ou les dépenses de l’hôpital, directement ou indirectement.
Le but de cet exposé est de vous donner les clés d’analyse de cet impact

- Les dias suivantes vous donnent un très bref aperçu des recettes et dépenses d’un hôpital.

Les Finances d’un hôpital

Le chiffre d’affaires

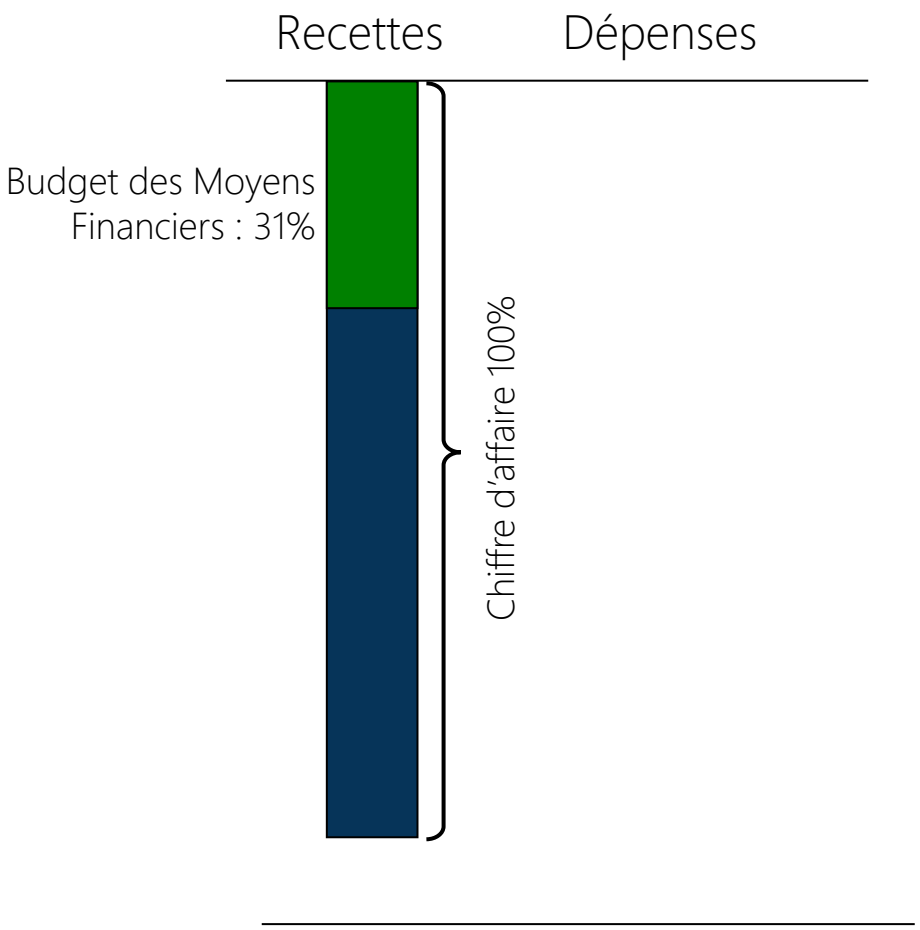


Le chiffre d’affaire représente l’ensemble des recettes des Cliniques pour son activité clinique

Nous nous basons pour cette présentation sur le réalisé 2025 (en pourcentage du chiffre d’affaires)

Les Finances d'un hôpital

Le Budget des Moyens Financiers



Le BMF couvre tous les frais résultant du séjour du malade en chambre à plus de deux lits et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'hôpital, y.c. pour l'hospitalisation de jour chirurgicale

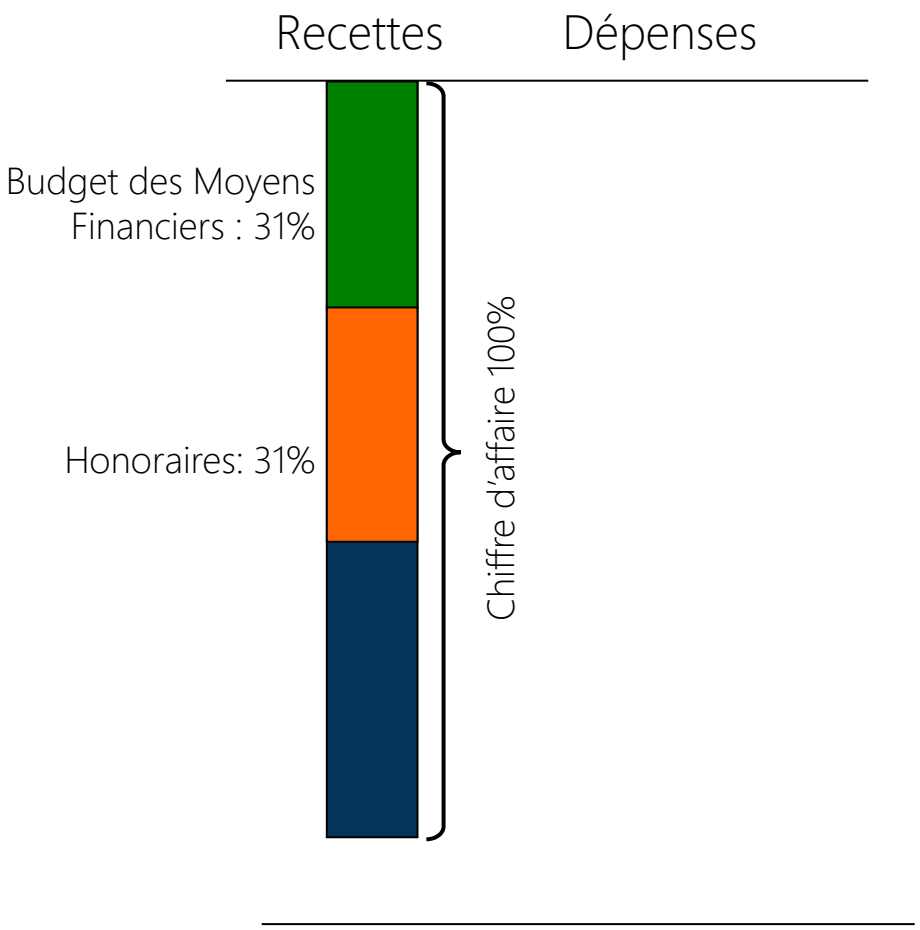
Ce prix couvre également l'infrastructure des Urgences, du Bloc d'accouchement, du Bloc opératoire et des Soins intensifs ainsi qu'une partie de la Pharmacie et une partie des coûts du personnel travaillant dans le secteur Ambulatoire

Des moyens spécifiques sont attribués aux hôpitaux académiques pour faire face à leurs missions d'enseignement et de recherche.

Le BMF est attribué en fonction de la durée de séjour « normale » de chaque patient (qui n'est donc pas sa durée de séjour réelle)

Les Finances d'un hôpital

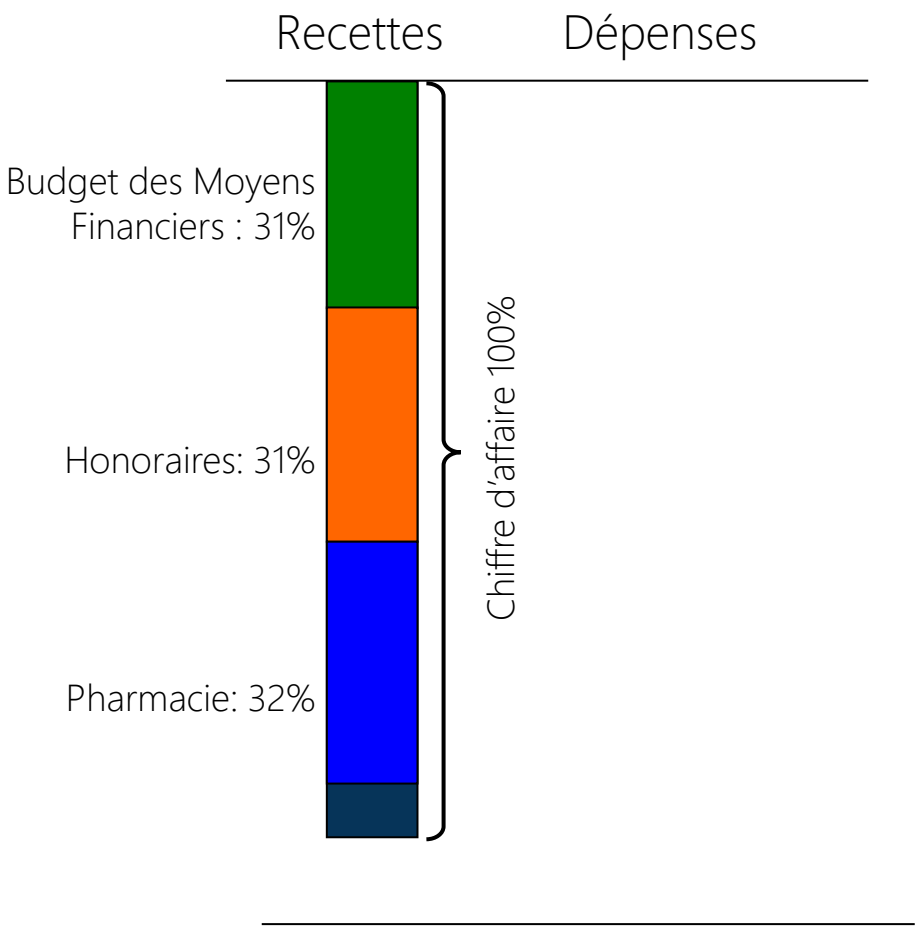
Les honoraires



Les honoraires médicaux servent à rémunérer les médecins qui effectuent les actes médicaux ainsi que tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ces actes : personnel, matériel, locaux, ….

Les Finances d'un hôpital

Les produits pharmaceutiques

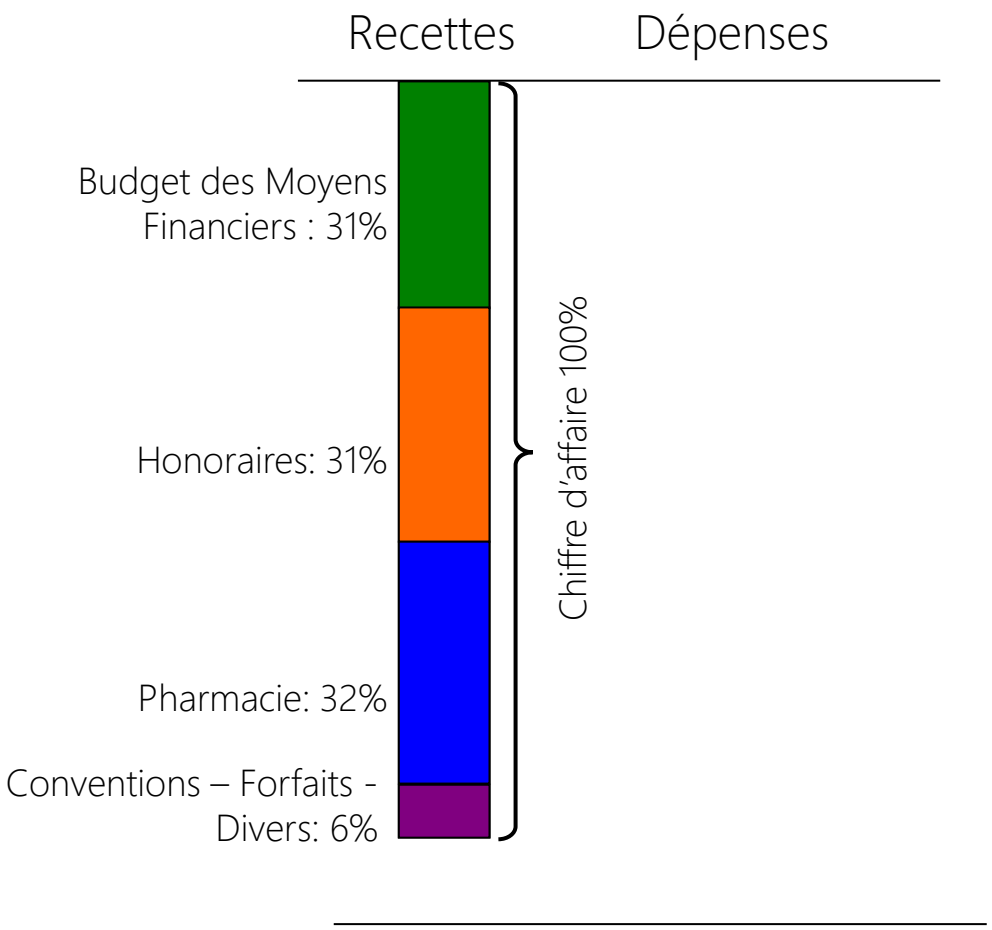


- Spécialités pharmaceutiques
- Médicaments génériques
- Bandes et autres matières plâtrées
- Matériel de synthèse (prothèses & implants)

Le matériel qui n'est pas spécifiquement enregistré comme remboursable par l'INAMI est réputé être à charge de l'hôpital

Les Finances d'un hôpital

Conventions – Forfaits – Divers



Hospitalisation de jour (non chirurgicale)

- Utilisation de la salle de plâtre
- Dialyses
- Conventions CUSL / INAMI
  - Standards : oxygénothérapie à domicile, auto-surveillance de la glycémie, mort subite, etc.
  - Spécifiques :Centre de Revalidation Neuropsychologique, Centre Thérapeutique pour Adolescents

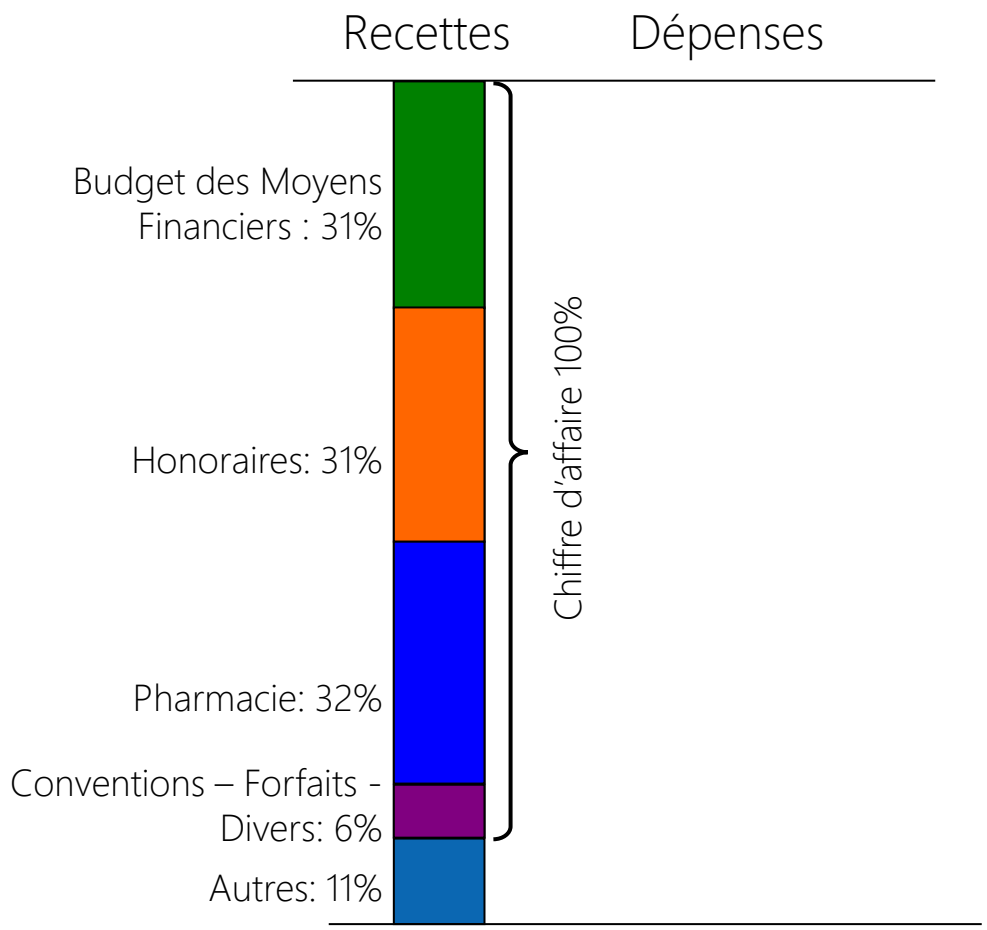
Divers

- Suppléments de chambre
- Frais divers refacturés aux patients

- Financement des constructions par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Les Finances d'un hôpital

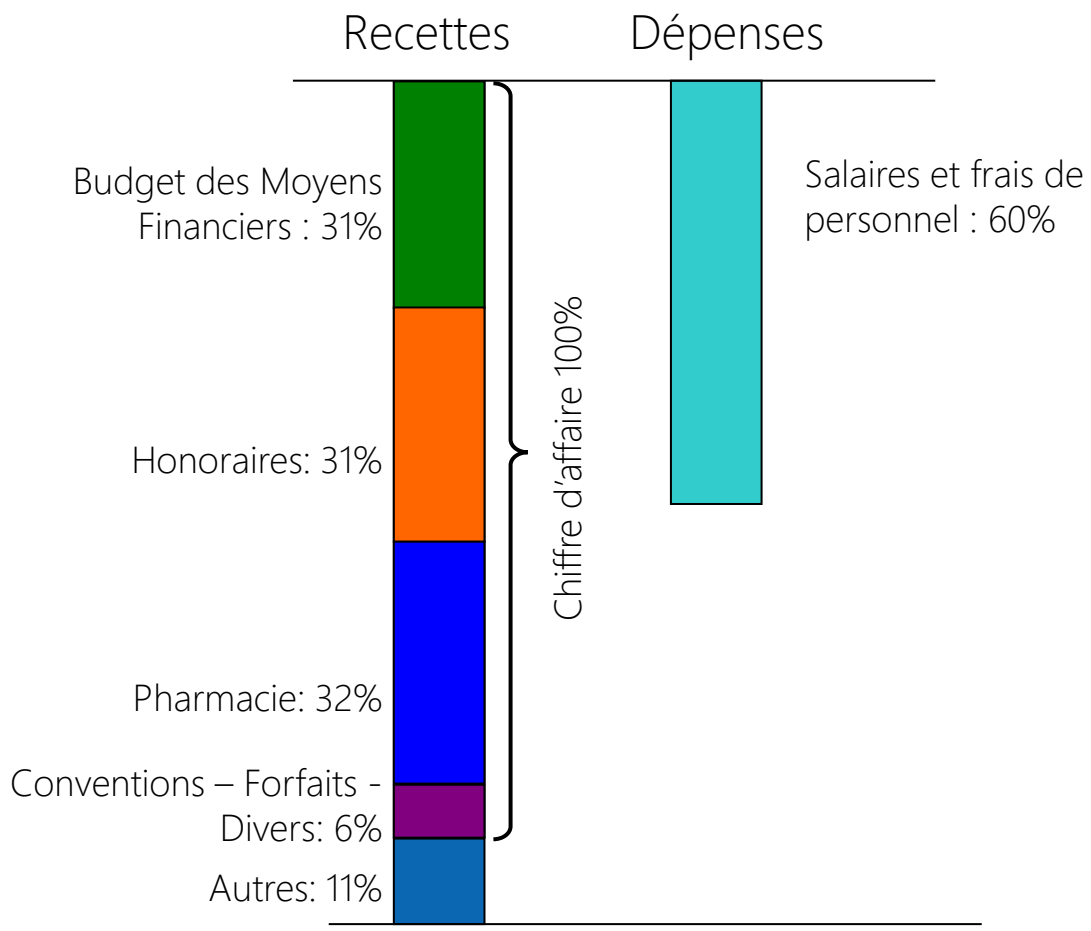
Autres produits d'exploitation



- Subsides d 'exploitation (ONE, Fédération Wallonie Bruxelles, Région bruxelloise, industrie, …)
- Convention UCL/ CUSL
- Financements F.B.I., Maribel social
- Recettes loyers, restaurant, auberge de jour, centre audio-visuel
- Refacturation de frais de personnel, d'achats et de services
- Subsides à la Recherche et mécénats

Les Finances d'un hôpital

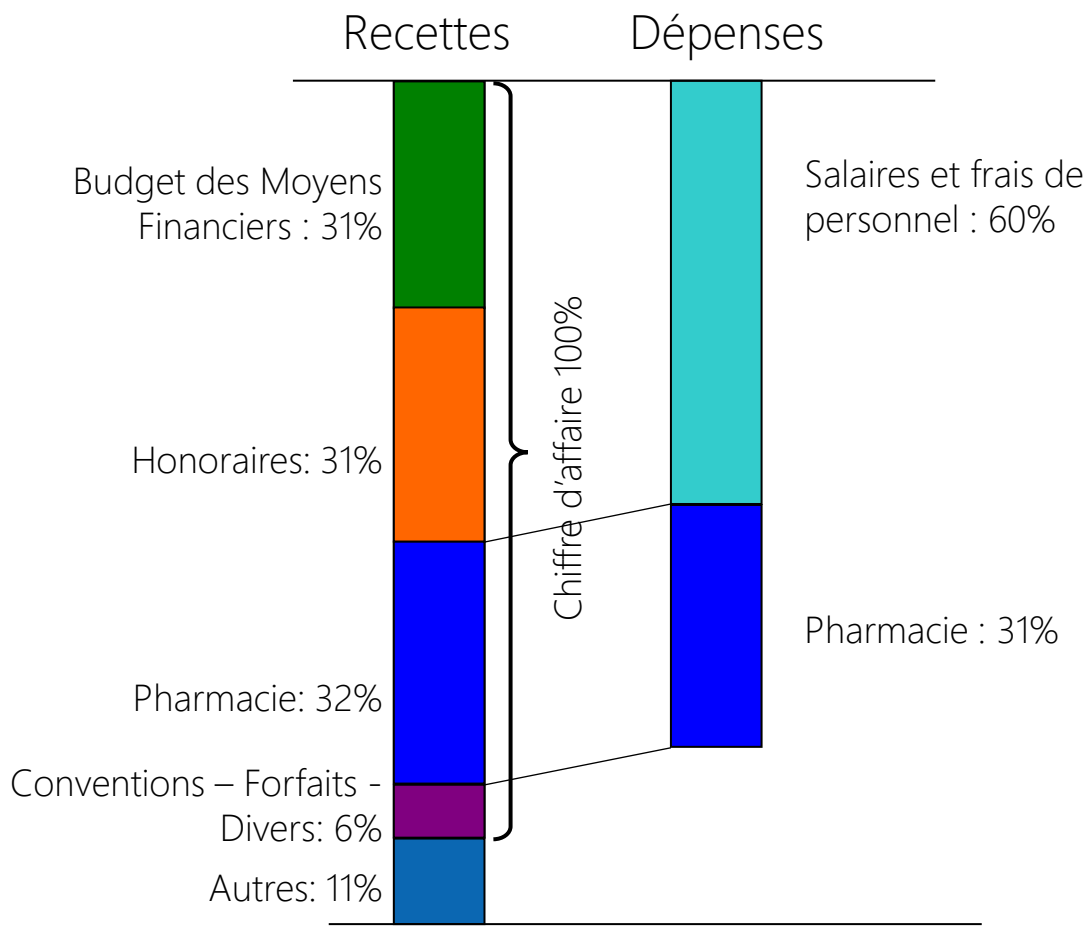
Salaires et frais de personnel



- Hôpital académique : minimum 70% de médecins mono-hospitaliers, temps plein, sous statut salarié (<> hôpitaux généraux)

Les Finances d'un hôpital

Les charges de pharmacie

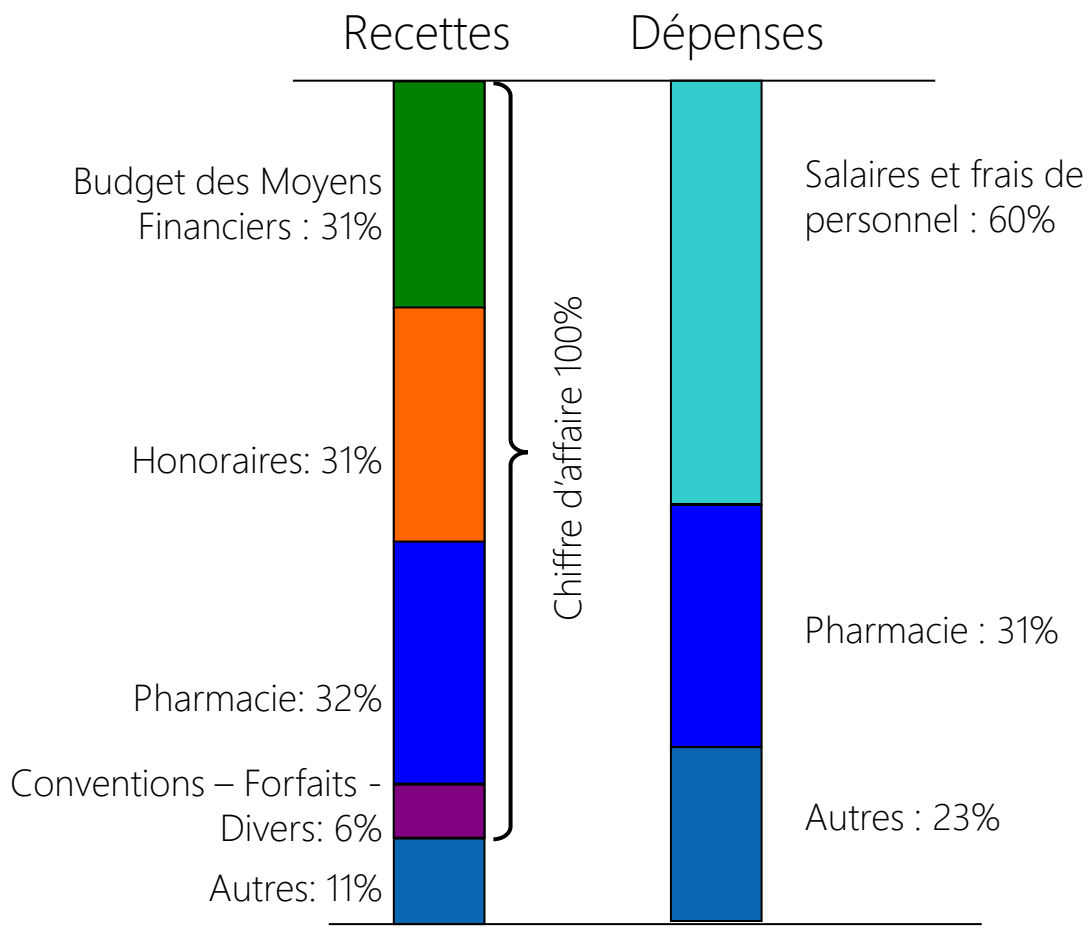


Marge très faible sur l'ensemble de la pharmacie/ DMI. Financement de l'activité de la pharmacie essentiellement assuré par le BMF.

Un très léger bénéfice par négociation des prix avec les fournisseurs (le prix de vente est imposé par l'INAMI)

Les Finances d'un hôpital

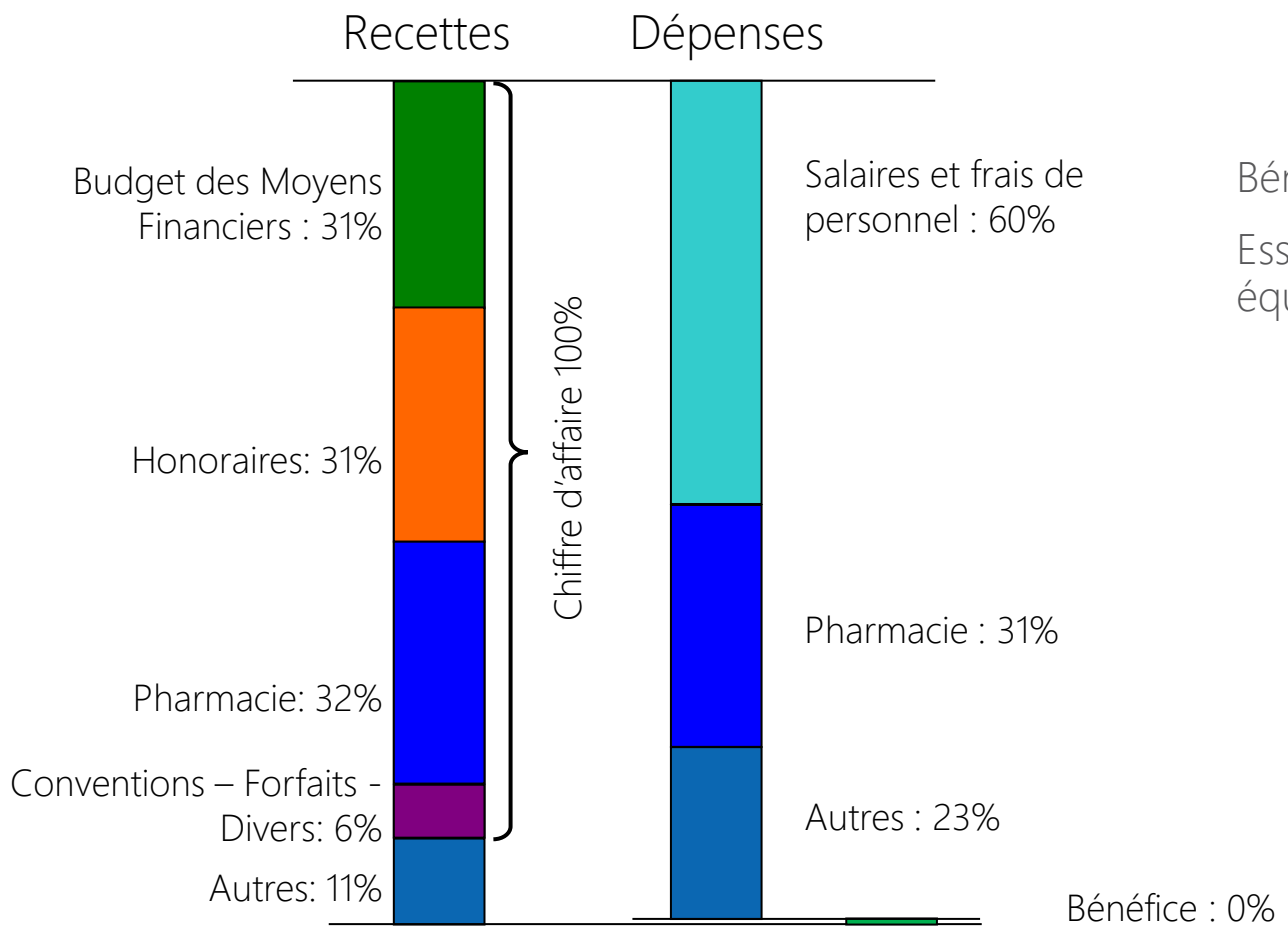
Autres charges



- Achats divers (énergie, réactifs, nourriture, maintenance, services informatiques, etc.)
- Amortissement des investissements

Les Finances d'un hôpital

Bénéfice/ Perte



Bénéfice de 1 à 3% selon les années/ les hôpitaux.

Essentiel pour dégager les moyens permettant d'investir en équipements et entretien des bâtiments.

1. Remarques préliminaires
2. Les finances d'un hôpital – Recettes et dépenses
3. **Mesurer la rentabilité d'un projet**
4. Votre projet

L’évaluation financière de votre projet

Une influence sur les recettes et sur les charges

- Chacun de vos projets influencera les recettes ou les charges de l’hôpital
- A la hausse ou à la baisse
    - Un projet peut augmenter les charges, mais aussi augmenter les recettes
    - Tout comme il peut diminuer les charges

… et peut-être diminuer les recettes tout en restant profitable

- L’évaluation financière de votre projet consistera donc à mesurer l’impact de votre projet vs la situation de départ.

Mais avant de passer à l’évaluation, il nous faut faire un rapide plongeon dans une notion comptable : l’amortissment

Deux types de dépenses

Seront mobilisées pour réaliser votre projet

- Dépenses d'investissements :
  - La valeur des biens durables acquis par les unités de production pour être utilisés pendant au moins un an dans leur processus de production : un bâtiment, un équipement, un logiciel, etc.
  - Comme ils vont supporter le processus de l'entreprise pendant plusieurs années, la charge d'un investissement est répartie sur sa durée de vie. C'est l'amortissement.
    - On amortit donc annuellement un investissement en fonction de sa durée de vie : si un équipement coûte 70,000€ et dure 7 ans, nous prenons 10,000€ par an en charge d'amortissement.
    - La particularité de l'amortissement est que ce n'est pas une dépense : la dépense est faite au moment de l'investissement (l'achat), mais la charge (l'amortissement) se fait sans dépense, sans sortie de cash.

- Dépenses de fonctionnement :
  - La valeur des biens qui sont consommés dans un délai inférieur à un an : du personnel, des consommables (pex. énergie, réactifs, matériel de soins, matériels disposables, etc.)
  - Ces dépenses sont directement et entièrement prises en charge.
    - Contrairement à l'amortissement, la dépense de fonctionnement implique bien une sortie de cash

Pour information

Dépense d'investissement

Définitions

La valeur des biens durables acquis par les unités de production pour être utilisés pendant au moins un an dans leur processus de production

Il s'agit de bien durables immobilisés

- Incorporels (généralement softwares, mais aussi frais de restructuration, goodwill, recherche), ou;
- Corporels
  - terrains
  - immeubles
  - équipement
  - matériel roulant
  - Immobilisés en construction

Les actifs immobilisés acquis par investissement sont portés à l'actif du bilan.

Pour information

Le bilan

Rappel

ACTIF	PASSIF
ce que l'Entreprise possède	ce dont l'entreprise dispose comme ressources = moyens de financement, càd - ressources propres - dettes
= EMPLOI DES FONDS	= ORIGINE DES FONDS

Le bilan

Pour information

ACTIF
VALEURS IMMOBILISEES NETTES - Frais d'établissement - Terrains - Constructions - Equipement
ACTIFS CIRCULANTS - Créances > 1 an - Stocks - Créances < 1 an - Disponible

Rangement par
LIQUIDITE CROISSANTE

PASSIF		
NON EXI-GIBLE	- Capitaux propres - Réserves - Résultat reporté - Subsides investiss. - Provisions	CAP. PER-MA-NENTS
EXI-GIBLE	- Dettes > 1 an	
	- Dettes < 1 an - Dettes financières - Dettes courantes - Dettes fiscales, salariales et sociales	

Rangement par
EXIGIBILITE CROISSANTE

Pour information

L'amortissement

Principe

- Consiste à enregistrer la perte de valeur subie par un actif immobilisé qui se déprécie avec le temps et avec l'usage.

- Trois fonctions selon trois optiques :

  1. Comptable : corriger la valeur comptable de l'actif qui subit une dépréciation (usure, obsolescence)

  2. Economique : répartir le coût initial sur la durée de vie utile du bien immobilisé.
     L'amortissement du bien est inclus dans les charges en tant qu'élément du prix de revient

  3. Financière : inclure dans les charges d'exploitation les capitaux nécessaires à la reconstitution du bien immobilisé (notion d'autofinancement)

- En comptabilité hospitalière, l'amortissement est linéaire (constant) sur une durée définie par arrêté royal.

L'évaluation financière du projet

- Le principe général d'évaluation d'un projet sera toujours de mesurer l'impact de ce projet sur l'argent encaissé ou décaissé par l'hôpital.
- La somme des encaissements et décaissements est appelée le cashflow.
  Nous allons donc nous attacher à évaluer le cashflow du projet, ou plutôt la variation de cashflow qu'il induit.

- Le cashflow n'est pas le bénéfice.
  - Le calcul du bénéfice prend en compte des amortissements, dont nous avons vu qu'ils n'induisent pas de dépense (la dépense a été faite au moment de l'investissement)
  - Dans notre modèle simplifié, on peut considérer que le cashflow est un bénéfice qui ne tient pas compte de l'amortissement (charge non décaissée) : le cashflow ne tient compte que des recettes et charges effectivement encaissées et décaissées.

- Le directeur financier ne regarde (quasiment) que le cashflow

Cashflows

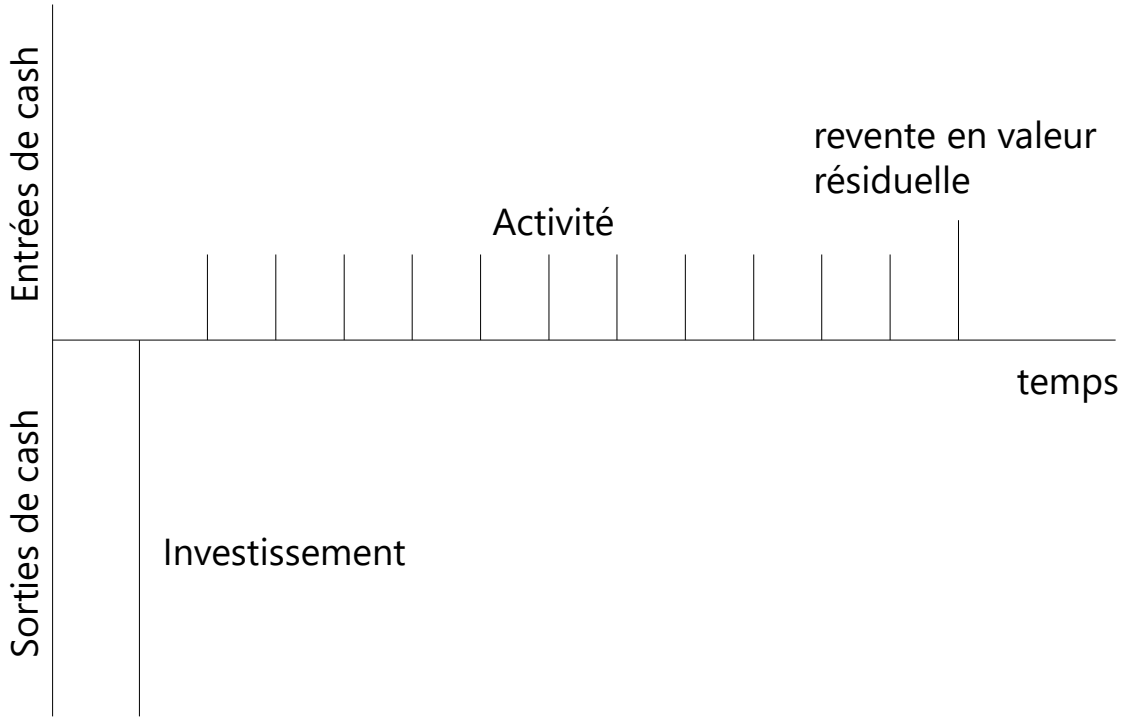
Un principe très simple : seuls les flux financiers comptent

Les questions sont :

- A partir de quel moment ai-je récupéré mon investissement ?
  - une période plus courte est toujours préférable
- Quel est le rendement sur la durée de vie espérée de l'investissement ?
  - calcul de la Valeur Actuelle Nette (Net Present Value)

Le graphique reprend un investissement simple et ses impacts. Dans l'évaluation d'un projet, vous devrez probablement considérer l'impact du projet sur les cashflows existant :

- Quelle est la situation des comptes avant le projet
- Comment évolue le CF global suite à la mise en œuvre du projet

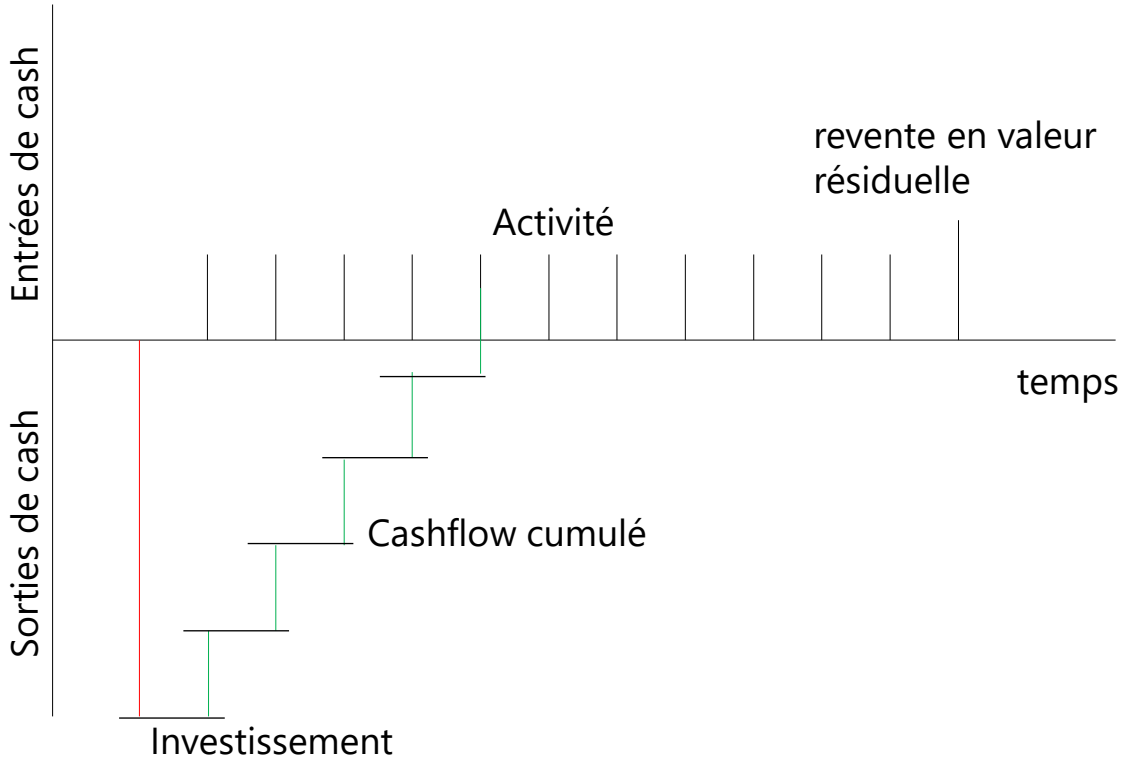


Méthodes de calcul

Seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité (payback period) est aisé à calculer

1. on calcule tous les cash flow futurs (achat, opérations, liquidation)
2. on mesure l'année pendant laquelle le cash flow cumulé devient positif : c'est le seuil de rentabilité.
   - Avec une petite complexité pour déterminer avec précision le moment dans l'année où on passe en positif
   - Dans l'exemple le CF cumulé devient positif dans le courant de la 4e année



Méthodes de calcul

Valeur actuelle nette

La Valeur Actuelle Nette (Net Present Value) est plus complexe

- on calcule tous les cash flows prévus, comme pour le seuil de rentabilité
- on actualise ensuite les cash flows futurs en tenant compte d'un taux d'intérêt (taux d'actaulisation)

$$V_{ActuelleNette} = \sum_{p=0}^{p=N} CF_{flux\ de\ tresorerie} \cdot (1+t)^{-p} - I + VR$$

- la somme des cash flow exprime alors le surplus (ou le déficit) de rentabilité par rapport au taux attendu.
  - le coût moyen du capital qui aura servi à faire l'investissement : p.ex. 4,0% aujourd'hui pour l'emprunt fait par un hôpital ASBL sur 10 ans, ou 7% à 10% si la Maison de Repos privée n'est financée que par du capital à risque. Dans ce cas, la VAN représente le return qui excède le coût du capital
  - le rendement d'un investissement alternatif (rarement utilisé dans les soins de santé). Si placer votre argent dans un actif de risque comparable rapporte X, alors la proposition qui vous est faite d'investir dans autre chose n'est à considérer que si le rendement dépasse ce X
  - l'inflation attendue. Les euros de demain valent moins que ceux d'aujourd'hui, et la méthode de la VAN permet de tenir compte de cette dépréciation.

Exemple de tableau simple de VAN

Temps →

Année	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Examens /an:													

Paramètres de calcul

DEPENSES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investissement													
Contrat Entretien													
Consommables													
Réparations													
Frais de Personn													
Coûts indirects													
Autres													
TOTAL DEPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dépenses (cash)

RECETTES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Honoraires													
JE													
Forfaits													
Actes Médico-Techn.													
Recettes indirectes													
Diminution éven													
TOTAL RECETTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Recettes (cash)

Différence = cashflow du projet

Remarques :

- nous calculons un CF, il n'y a donc pas d'amortissement pris en compte
- Votre projet n'implique pas nécessairement d'investissement, et il n'y a donc pas nécessairement de dépense en année 0
- N'oubliez jamais de comparer la situation « sans projet » vs la situation « avec projet »

Exemple plus complex

Un centre de protonthérapie….

Proton therapy business case

Sum of cash flow	**-190**	**k EUR**
INAMI reimbursement required to get sum CF=0	**43,7**	**k EUR**
Patient number treated per yr	**110**	

			Building			Runnin														
			BY1	BY2	BY3	RY1	RY2	RY3	RY4	RY5	RY6	RY7	RY8	RY9	RY10	RY11	RY12	RY13	RY14	RY15
Revenues	Clinical	Patient capacity				211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
		Patient treatment potential				110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		Patient actual capture	0	0	0	50,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nb of patient	0	0	0	55	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		Reimbursement per patient	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
		Total incl TVA	-	-	-	2.404	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807
		TVA on CUSL margin	-	-	-	280	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
		Total excl TVA	-	-	-	2.123	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	Research					720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
	Subsidy		667	667	667															
	Total (k EUR)		**667**	**667**	**667**	**2.843**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**4.830**
OPEX	Recurring	Staff				789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
		Utilitites				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Security				371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
		Maintenance				1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
		Property taxes				0	0	0	0	0	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
		Marketing/communication				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	One-off	Marketing				250														
	Total (k EUR)		**-**	**-**	**-**	**2.790**	**2.540**	**2.540**	**2.540**	**2.540**	**2.672**	**2.672**	**2.672**	**2.672**	**2.672**	**2.672**	**2.672**	**2.672**	**2.672**	**2.672**
EBITDA (k EUR)			**667**	**667**	**667**	**53**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**
Taxes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX	Building		4.000																	
	PT equipment	SW	500																	
		HW	6.000	6.000	6.000															
	Upgrade provision		1.000																	
	Decommissioning				750															
	Total (k EUR)		**11.500**	**6.000**	**6.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Loans	WR loan		4.000																	
	bank loan			6.100	7.150															
	Total (k EUR)		**4.000**	**6.100**	**7.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
FINANCING COSTS	Intérêt intercalaires			765	897															
	Reimbursement RW (P+I)					376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376
	Reimbursement Bank (P+I)					1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
	Total (k EUR)		**-**	**765**	**897**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**	**1.621**
Cash flow			**- 6.833**	**2**	**170**	**-1.568**	**668**	**668**	**668**	**668**	**536**	**536**	**536**	**536**	**536**	**536**	**536**	**536**	**536**	**536**

1. Remarques préliminaires
2. Les finances d'un hôpital – Recettes et dépenses
3. Mesurer la rentabilité d'un projet
4. Votre projet

Analyse financière de projet

Votre défi des prochaines semaines

- Identifier les éléments des recettes et dépenses de l'hôpital qui seront influencées par votre projet
  - Directement ou indirectement

- Estimer l'impact du projet sur ces recettes et dépenses
  - De façon réaliste, prudente et ambitieuse, votre scénario « probable »

- Vous essayer à imaginer des scénarios : comment évolue le cashflow si…
  - Tout ne se réalise pas comme prévu ?
  - Le projet fonctionne mieux que prévu ?

⇨ Analyse de sensibilité du projet

Merci pour votre attention

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser